藥華醫藥股份有限公司

TWSE 6446

PharmaEssentia

免責聲明

This presentation contains forward-looking statements, including statements regarding the plans and expectations for commercializing BESREMi® in the United States and globally, and the potential benefits or competitive position of BESREMi®. For those statements, we claim the protection of the safe harbor for forward-looking statements contained in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and similar legislation and regulations under Taiwanese law. These forward-looking statements are based on management expectations and assumptions as of the date of this presentation, and actual results may differ materially from those in these forward-looking statements as a result of various factors. These factors include PharmaEssentia's ability to launch BESREMi® in the United States and globally, whether BESREMi® is successfully commercialized and adopted by physicians and patients, the extent to which reimbursement is available for BESREMi®, and the ability to receive FDA and other regulatory approvals for additional indications for BESREMi®. Any forward-looking statements set forth in this presentation speak only as of the date of this presentation. We do not undertake to update any of these forward-looking statements to reflect events or circumstances that occur after the date hereof.

藥華藥係研發、臨床、製造暨行銷的全方位創新醫藥公司

藥華藥的商業化產品和研發產品線

ROPEG
(Ropeginterferon alfa-2b)

- 已獲核准用於治療所有成人真性紅血球增多症（PV）患者
- “首個美國FDA核准，適用於所有既往療程患者的治療方案”
- 早期介入－擺脫放血治療

成長關鍵動能

- 擴大全球PV市場布局
- 預期於 2026 年取得多國原發性血小板增多症（ET）藥證
- 早期前骨髓纖維化（PMF）的第三期臨床試驗收案中，預計於 2028 年取證
- 近 10 項研究者自行發起之臨床試驗案（IIT）持續推進，拓展 MPN 以外新適應症

研發

- 約占年度營業費用40%

具高度潛力的產品線

- 最大化創新 PEG-細胞激素（cytokines）平台
- 開發多個候選藥物
  - 抗體藥物偶聯物（ADCs）
  - 雙特異性抗體（Bi-specific）
  - 細胞治療（Cell-therapy）

藥華藥 (6446.TW)

公司成立於
2003

全球員工人數
2026年將成長至1,000人

總部及研發
台北，台灣

商業營運(子公司)
波士頓（美國）、東京、首爾、北京、香港、新加坡

合作夥伴
Pint（拉丁美洲）、Forus（加拿大）

2025 全球營收
5.04億美元
年增66%

全方位整合的製造能力

領導團隊擁有來自全球知名藥廠與生技公司的豐富經驗
兼具創新研發實力與卓越的商業執行力

詹青柳
博士

董事長

IONIS

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

林國鐘
博士

創辦人暨執行長

MONSANTO

Biogen

黃正谷
博士

台灣 總經理

AMGEN

Ligand

秦小強
醫學博士

醫學長

BAYER

SymBio Pharmaceuticals

immunogen

林俐伶
博士

科學長

Pfizer

sanofi

PharmaEssentia

關鍵里程碑（2003-至今）：從實驗室到創新藥上市

2003
藥華藥由一群多年海外生技經驗的科學家歸國成立

2012
原料藥生產
台中廠開工

2016
7月19日
於台北櫃買中心上櫃

2019.2
ROPEG
獲歐盟上市許可

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

2021.10
ROPEG
於10月13日
獲韓國上市許可

KOREA MFDS

2023.3
ROPEG
於3月27日
獲日本上市許可

pmda JAPAN

研發　臨床試驗　生產　銷售

2005
開發旗艦藥物
Ropeginterferon alfa-2b (ROPEG, P1101)

2009
US FDA通過
ROPEG進入
第一期臨床試驗

2013
ROPEG第三期臨床試驗啟動

2018
台中廠取得歐盟GMP 認證證書

FDA 食品藥物管理署 Food and Drug Administration

2020.5
ROPEG
獲台灣核准許可

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

2021.11
ROPEG於11月13日
獲美國FDA藥證核准

2024.1
1月25日
於臺灣證交所上市

PharmaEssentia

ROPEG具優異的安全性及有效性，成為40年來第一個FDA核准用於真性紅血球增多症（PV）創新型長效干擾素

干擾素於1980年代獲FDA核准

因半衰期短及副作用不可耐受，使用受限

兩種聚乙二醇化干擾素被FDA核准

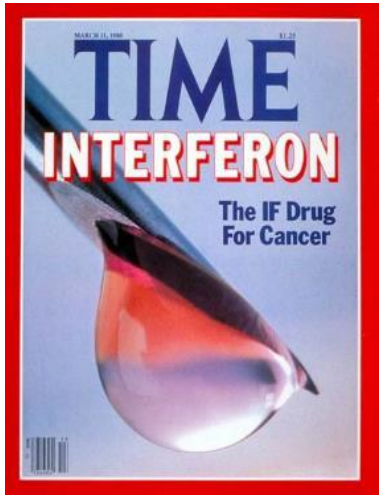
給藥頻率雖改善，副作用仍難以承受

ROPEG為單一同分異構體，擁有創新結構

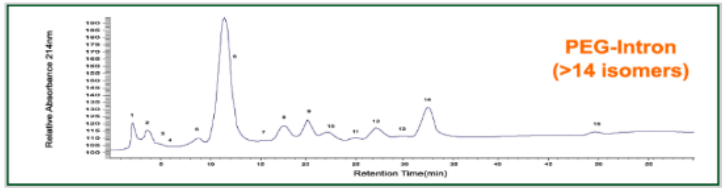
以單一主要形式存在，耐受性佳

1957 >> 1980s >> 2000s >> 2020s

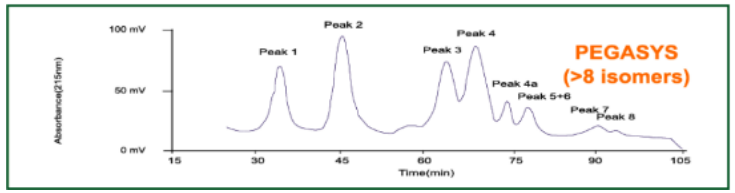
干擾素
首次被發現



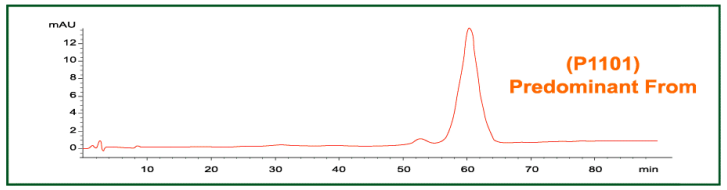
PEG-Intron® (Merck) PEG Interferon alfa-2b, for HCV[1]



Pegasys® (Roche) *PEG Interferon alfa-2a, for HCV & HBV*



ROPEG (PharmaEssentia) *RopegInterferon alfa-2b, for PV*



- Predominantly single isomer form of interferon alfa-2b
- Proven safety profile with low discontinuation rates
- Extended half-life enables less frequent dosing – every 2 weeks Subcutaneous injection

FDA Approves Treatment for Rare Blood Disease

Treatment is First FDA-Approved Option Patients Can Take Regardless of Previous Therapies

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION

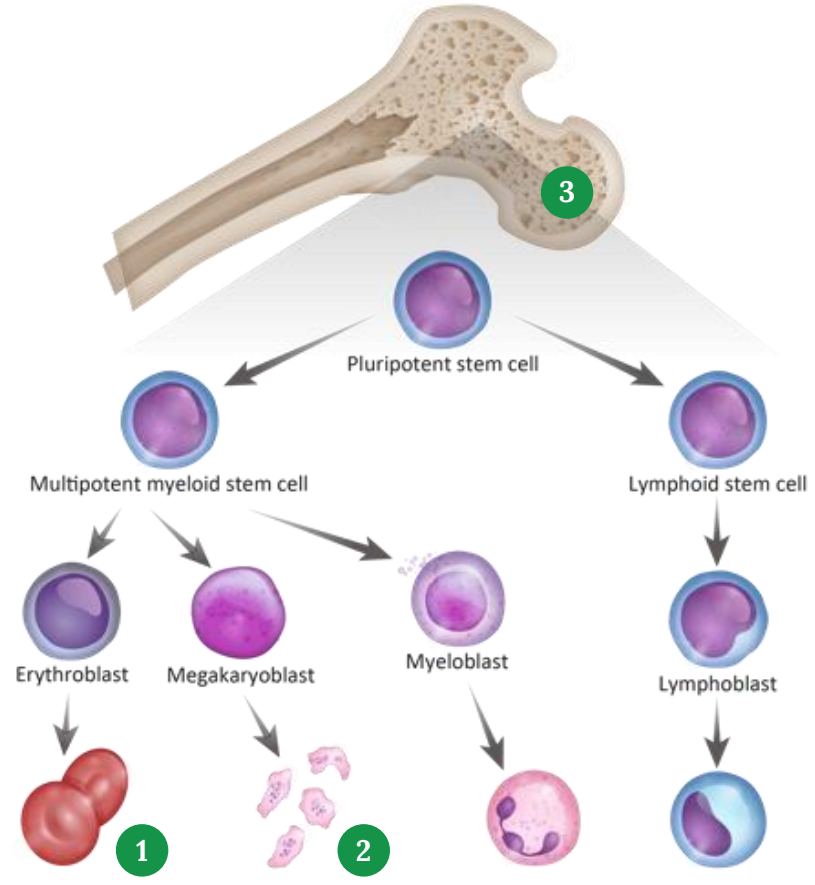
1. Adopted from Y .-S .Wang et al . Advanced Drug Delivery Reviews, 2002

PharmaEssentia

治療新希望：ROPEG改寫 MPN治療未來，迎向新曙光

造血幹細胞
突變[1]

血球細胞
過度增生[2,3]



紅血球增多　血小板增多　白血球增多

骨髓增生性腫瘤（MPNs）的分類

1. **真性紅血球增多症 (PV)**
   與骨髓幹細胞分化相關，造成紅血球的過度增生
2. **原發性血小板過多 (ET)**
   與骨髓幹細胞分化相關，造成血小板的大量增生
3. **骨髓纖維化 (MF)**
   與骨髓幹細胞相關，發炎及漸進的骨髓結疤

CALR, calreticulin, a multifunctional protein; JAK2, Janus kinase 2; MPL. thrombopoietin receptor.

1. Titmarsh, GJ., et al. *Am. J Haematol*. 2014;89:581–587. 2 Galán-Díez M, et al. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2018;8(7):a031328. 3. Boissinot M, et al. *Cancers*. 2014;6(3):1631-1669.

PharmaEssentia

全球MPN治療市場規模逾200億美元
ROPEG有望引領下一波治療創新

骨髓增生性腫瘤 (MPN)

全球市場規模（2025）

$15.33Bn

全球PV市場規模

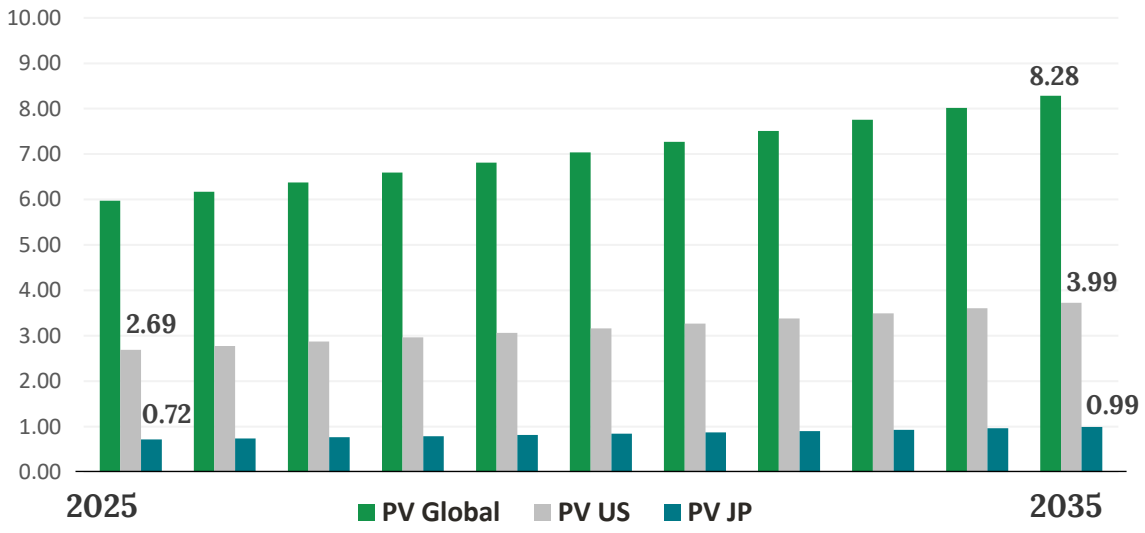
CAGR
(2025-2035)
3.32%

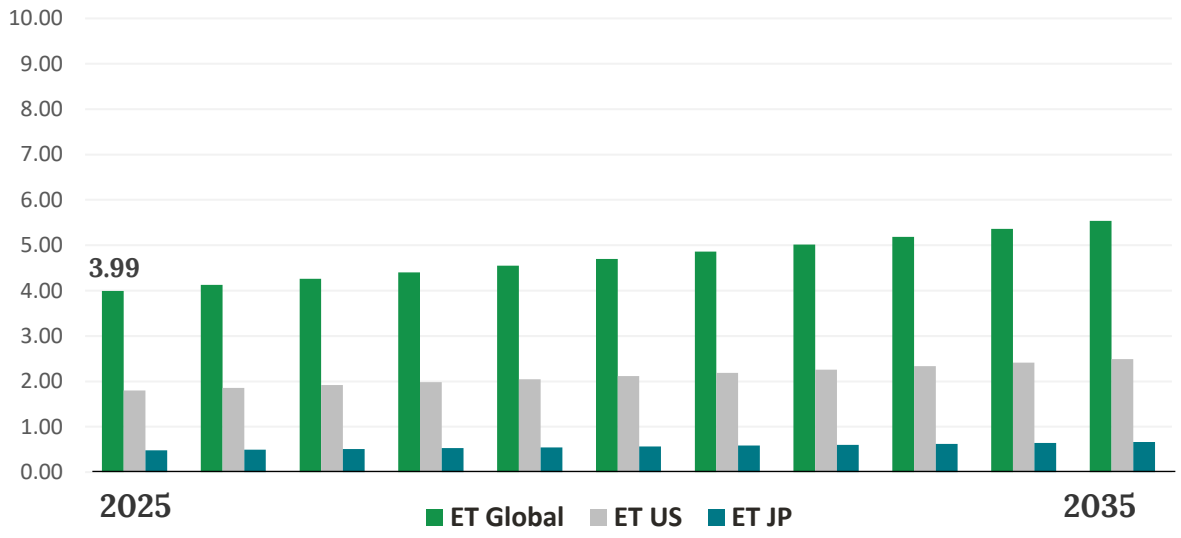
全球市場規模（2035）

$21.25Bn

全球ET市場規模

Unit : USD Billion





PharmaEssentia

Source: 1. Myeloproliferative Neoplasms Treatment Market Forecast, 2032; 2. Aetiology of Myeloproliferative Neoplasms – PMC ; 3. Polycythemia Vera Market Size, Analysis and Forecast ;
4. Myeloproliferative Disorders Treatment Market Report 2035 - Size, Share, Trends; 5. Market Research Future analysis; 6. analyst assumptions: DelveInsight, GlobalData, Coherent

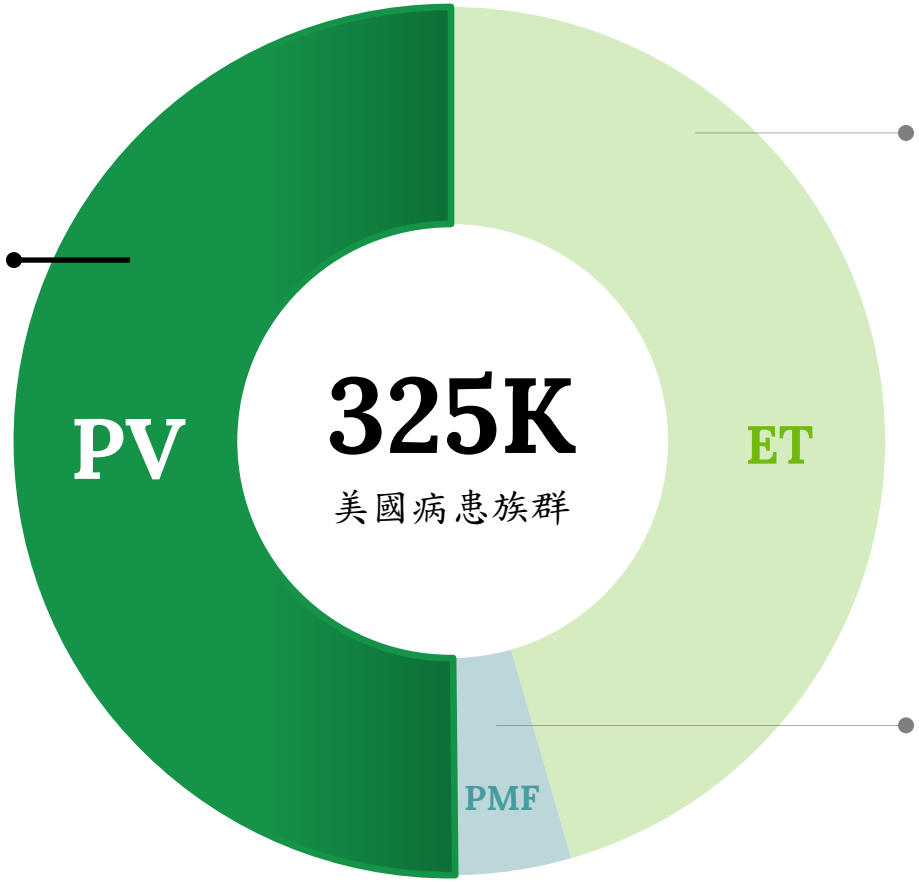
美國PV患者市場潛力巨大

擴大全球版圖，讓更多 PV 患者受惠於 ROPEG

163K

真性紅血球增多症（PV）

- 2019 歐盟藥證
- 2021 美國藥證
- 2023 日本藥證
- 2024 中國、新加坡、馬來西亞藥證
- 2025 巴西、阿根廷、香港藥證



148K

原發性血小板過多症 (ET)

- SURPASS –2025.01.06 主要數據讀出
- 申請ROPEG進入NCCN指南
- 2025 已完成中國、台灣、及日本送件
- 2025.10.30 已完成美國送件
- 2026.08.30 目標審查完成日期 (PDUFA date)

14K

早前期原發性骨髓纖維化 (PMF)

- 三期臨床試驗已啟動，預計2026年Q1完成收案

Patient numbers are U.S. prevalence from PharmaEssentia market research
*Source: PharmaEssentia Internal Analyses

PharmaEssentia

ROPEG用在PV全球核准已近50個國家，持續拓展病患治療版圖

歐盟核准上市
核准日期/2019.2.15

TFDA核准上市
核准日期/2020.5.5

韓國 核准上市
核准日期/2021.10.13

美國FDA核准上市
核准日期/2021.11.13

澳門
核准日期/2022.09.14

日本 核准上市
核准日期/2023.3.27

新加坡 核准上市
核准日期/2024.5.29

馬來西亞 核准上市
核准日期/2024.6.11

中國 核准上市
核准日期/2024.6.28

巴西
核准日期/2025.3.17

阿根廷
核准日期/2025.6.17

香港
核准日期/2025.10.6

哥倫比亞
送件日期/2024.4.24

墨西哥
送件日期/2024.9.27

越南
送件日期/2025.4.1

加拿大
送件日期/2025.7.18

PharmaEssentia

NCCN指南推薦ROPEG為PV低風險及高風險患者的唯一一線治療

NCCN 指南中關於 PV 治療的重點更新

低風險PV的治療方案

≤60歲，並且沒有血栓歷史

- 管理心血管危險因子
- 阿斯匹靈
- 放血

→

- 監控是否有新的血栓形成或出血
- 評估是否需進行降血球治療，並監測疾病進展

→ 有症狀且可能需要降血球治療 (例如:新的血栓形成、頻繁放血、脾臟腫大等) → **首選方案:**
- 臨床試驗 或
- **Ropeginterferon alfa-2b-njft**

其他推薦方案:
- HU 或
- Peginterferon alfa-2a

→ 無症狀且不需進行降血球治療 → 持續使用阿斯匹靈加放血

高風險PV的治療方案

>60歲 或 有血栓歷史

- 管理心血管危險因子
- 阿斯匹靈
- 放血

降血球治療方案
首選方案:
- HU 或
- **Ropeginterferon alfa-2b-njft**

其他推薦方案:
- Peginterferon alfa-2a

→

- 監控是否有新的血栓形成或出血
- 評估是否需進行降血球治療，並監測疾病進展

→ 反應不佳 或 無反應 → **評估是否需更換細胞減量療法方案** (例如:對先前細胞減量療法耐受性不佳或產生抗藥性、新的血栓形成或出血、頻繁放血、脾臟腫大等)

→ 有效緩解 → 持續治療方案

NCCN Guideline	2025 Version 2
低風險	**首選方案:** **Ropeginterferon alfa-2b-njft** **(唯一首選療法)** **其他推薦方案:** Hydroxyurea Peginterferon alfa-2a
高風險	**首選方案:** Hydroxyurea **Ropeginterferon alfa-2b-njft** **(唯一首選干擾素)** **其他推薦方案:** Peginterferon alfa-2a

PharmaEssentia

經證實的長期安全性、療效及對驅動基因突變的有效控制

Ropeginterferon alfa-2b (CONTI-PV[3]) | 2021獲美國FDA核准

完全血液反應 Overall CHR

Discontinued patients in these data were removed from future analysis

76.2%

(48 / 63)

免放血率 Phlebotomy-free rates

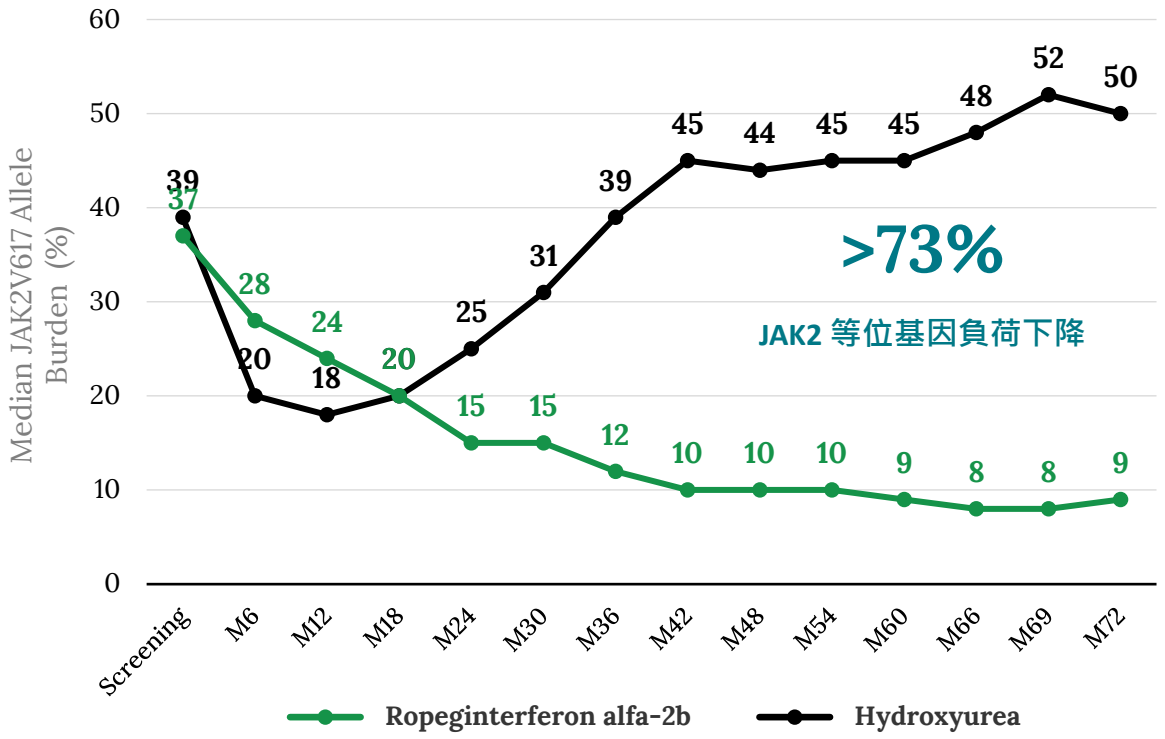
Percentage of patients in which no phlebotomies were required to maintain Hct <45%, among patients with available data

81.4%

(57 / 70)

PROUD / CONTINUATION PV Study

Median JAK2 V617F Allele Burden (%)



3.Gisslinger, H. et al., HemaSphere 6():p 97-98, June 2022. 4.Alvarez-Larran A, et al. Haematologica. 2017;102(1):103-109.
5.Bewersdorf JP, et al. Leukemia. 2021;35:1643-1660

PharmaEssentia

低風險PV患者僅靠放血不足以控制血球比容 (Hct)，早期介入至關重要

NCCN 指南中關於 PV 治療的重點更新

低風險PV的治療方案

≤60歲，並且沒有血栓歷史

- 管理心血管危險因子
- 阿斯匹靈
- 放血

→

- 監控是否有新的血栓形成或出血
- 評估是否需進行降血球治療，並監測疾病進展

→

有症狀且可能需要降血球治療
(例如:新的血栓形成、頻繁放血、脾臟腫大等)

→

首選方案:
臨床試驗 或

Ropeginterferon alfa- 2b-njft

其他推薦方案:
HU or

Peginterferon alfa-2a

無症狀且
不需進行降血球治療

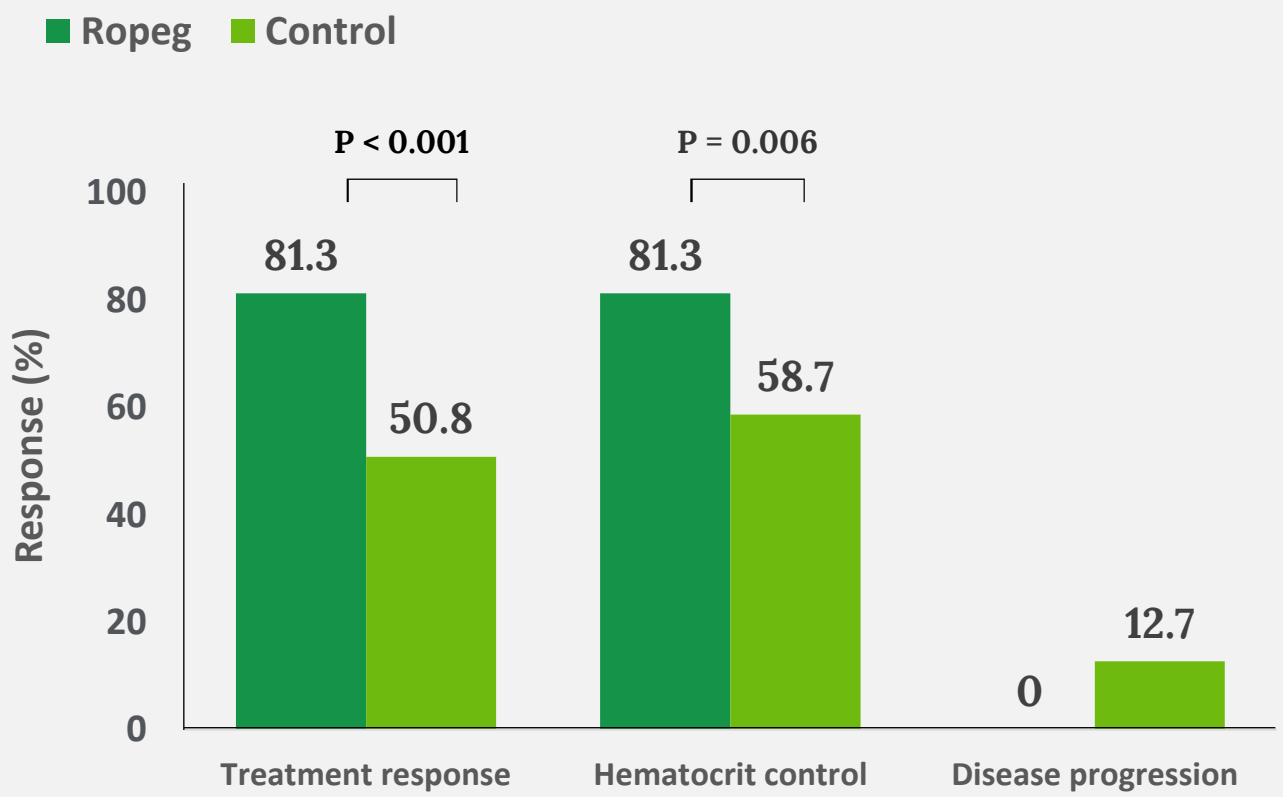
→

持續使用
阿斯匹靈加放血

NCCN指南	2025 Version 2
低風險	**首選方案:** **Ropeginterferon alfa-2b-njft** **(唯一首選療法)** **其他推薦方案:** Hydroxyurea Peginterferon alfa-2a
高風險	**首選方案:** Hydroxyurea **Ropeginterferon alfa-2b-njft** **(唯一首選干擾素)** **其他推薦方案:** Peginterferon alfa-2a

PharmaEssentia

早期介入：Ropeg 合併放血治療
於低風險 PV 病人中可顯著降低放血次數，並有效控制血球比容 (Hct)



武田製藥 (Takeda) 和 Protagonist

2026.01.05

宣布提交 Rusfertide 治療真性紅血球增多症（PV）的新藥上市申請（NDA）

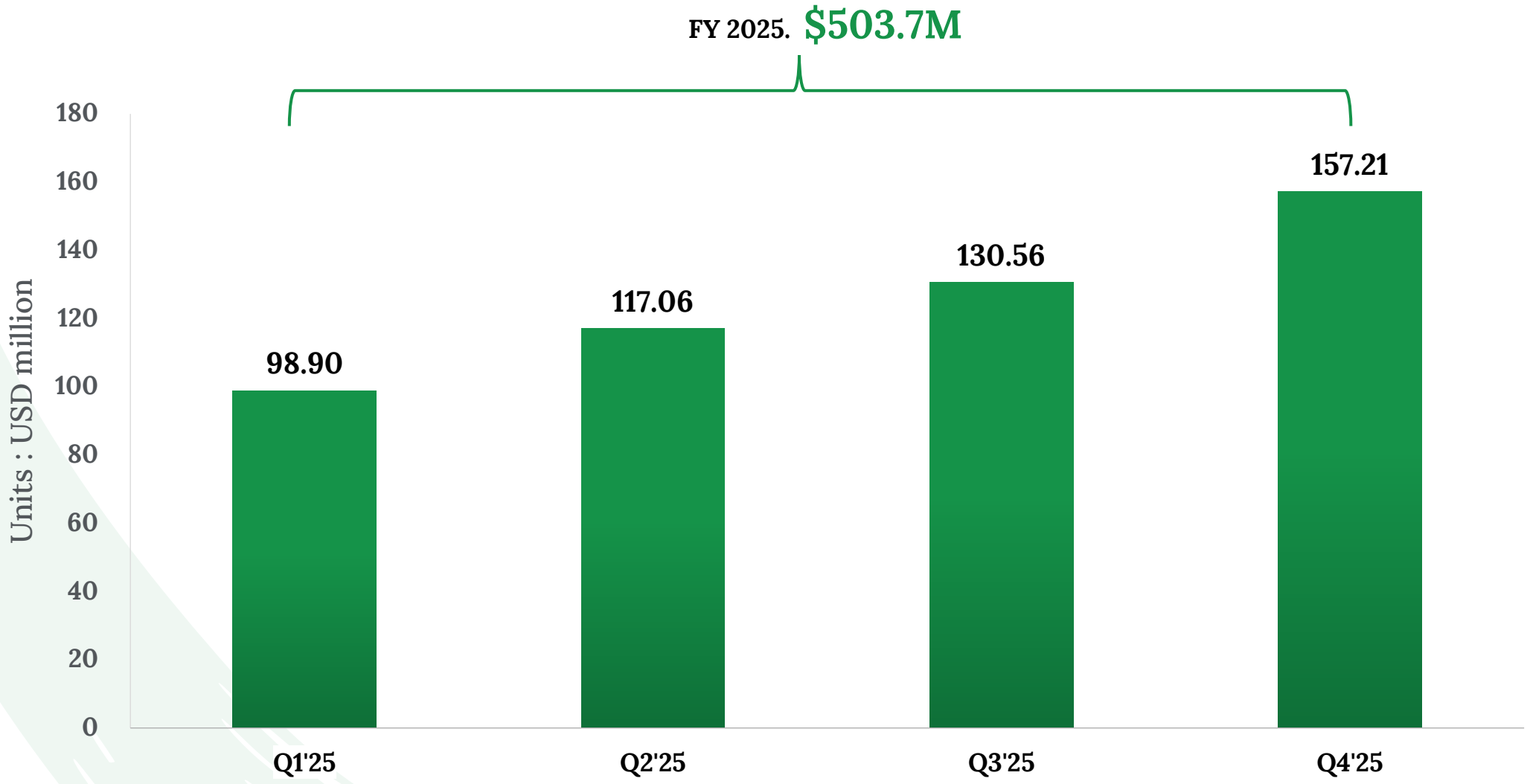
數據顯示有潛力改變PV治療格局，減少頻繁放血，並有效控制血球比容 (Hct)。

Data Underscore the Potential to Shift the Treatment Paradigm for PV Patients to Reduce the Burden of Frequent Phlebotomies and Meaningfully Improve Hematocrit (Hct) Control

PharmaEssentia

Source: Barbui et al. NEJM Evid. 2023
https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2025/new-drug-application-pv/

集團2025年營收超過5億美元



PharmaEssentia

- The quarterly TWD/USD revenue exchange rate is based on the average of the Customs late-month (21st–31st) exchange rates [https://reurl.cc/W8gvG9] over each three-month period.
- For Q4 2025, the average exchange rate for October to December was 31.048, which has been applied to the revenue figures.

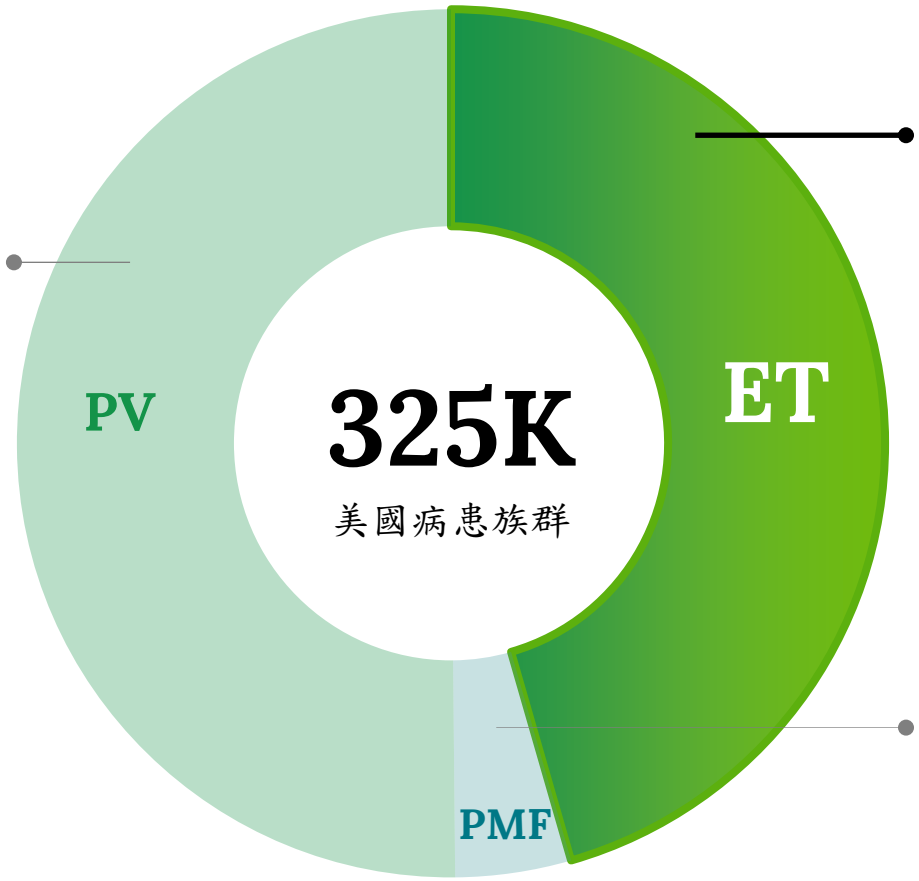
預計2026年取得美國及全球ROPEG ET藥證，惠及約 10 萬名患者

美國 ET 患者族群將市場潛力擴大一倍

163K

真性紅血球增多症（PV）

- 2019 歐盟藥證
- 2021 美國藥證
- 2023 日本藥證
- 2024 中國、新加坡、馬來西亞藥證
- 2025 巴西、阿根廷、香港藥證



148K

原發性血小板過多症 (ET)

- SURPASS –2025.01.06 主要數據讀出
- 申請ROPEG進入NCCN指南
- 2025 已完成中國、台灣、及日本送件
- 2025.10.30 已完成美國送件
- 2026.08.30 目標審查完成日期 (PDUFA date)

14K

早前期原發性骨髓纖維化 (PMF)

- 三期臨床試驗已啟動，預計2026年Q1完成收案

Patient numbers are U.S. prevalence from PharmaEssentia market research
*Source: PharmaEssentia Internal Analyses

PharmaEssentia

ET藥證完成送件，預計2026年獲准

有望成為FDA 30年來ET新藥核准的關鍵突破，領航MPN市場

中國 NMPA藥證申請

送件日期: 2025.07.16

預計藥證取得日期: 2026.7

美國 FDA藥證申請

送件日期: 2025.10.30 (EST)

目標審查完成日期 (PDUFA date): 2026.08.30

日本 PMDA藥證申請

送件日期: 2025.09.18

預計藥證取得日期: 2026.9

加拿大 藥證申請

送件日期: 準備中

台灣 TFDA藥證申請

送件日期: 2025.9.5

預計藥證取得日期: 2026.3

臨床試驗數據支持 sBLA 適應症擴展申請

SURPASS-ET
ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA

一項52週、開放性、隨機分配、有效藥物對照之臨床三期試驗，用於評估藥物動力學，並比較P1101與Anagrelide作為二線治療的療效、安全性及耐受性

- 全球三期臨床試驗
- 收案174名高風險ET患者，皆未曾接受IFN-a治療，且對 HU不耐受或產生抗藥性

SURPASS-ET的臨床結果為安全性及有效性的關鍵證據，而EXCEED-ET則作為確認性證據 (confirmatory evidence)。

最新進展: 自2025年12月29日起，美國ET藥證申請進入實質審查階段

EXCEED ET
ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA

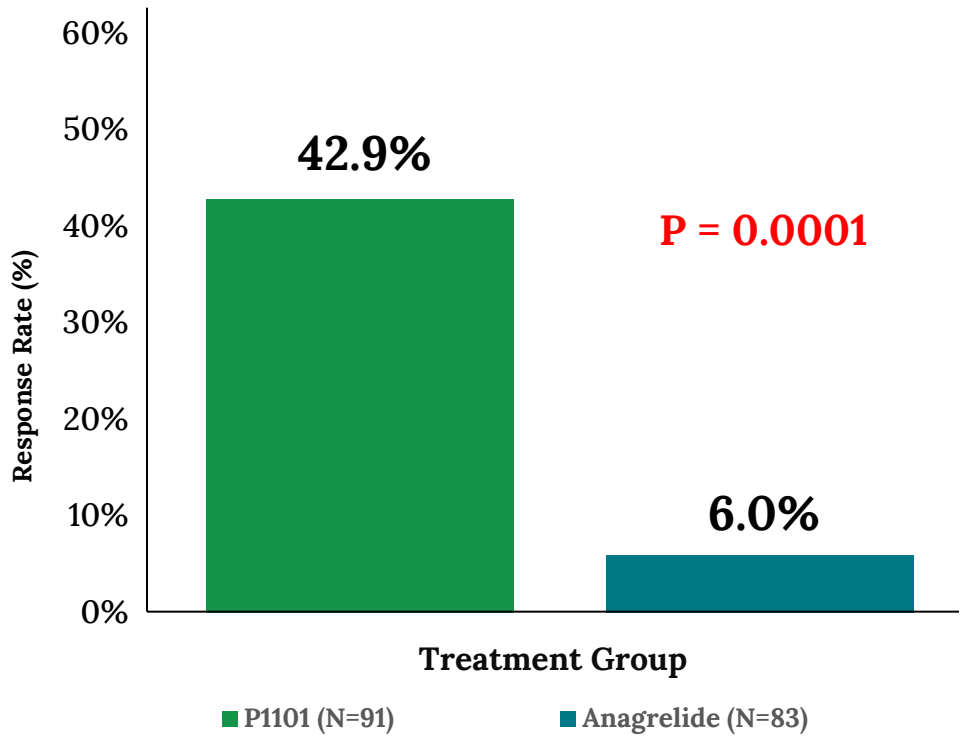
一項56週、單臂、多中心的IIb期臨床試驗，用於評估Ropeginterferon Alfa-2b-njft (P1101) 在原發性血小板過多症(ET)成人患者中的療效、安全性及耐受性

- 單臂臨床試驗 (僅北美地區)
- 超額收案91名患者，包括未接受細胞減量療法、干擾素、以及ruxtolitinib的患者，或曾接受 HU和/或anagrelide的患者

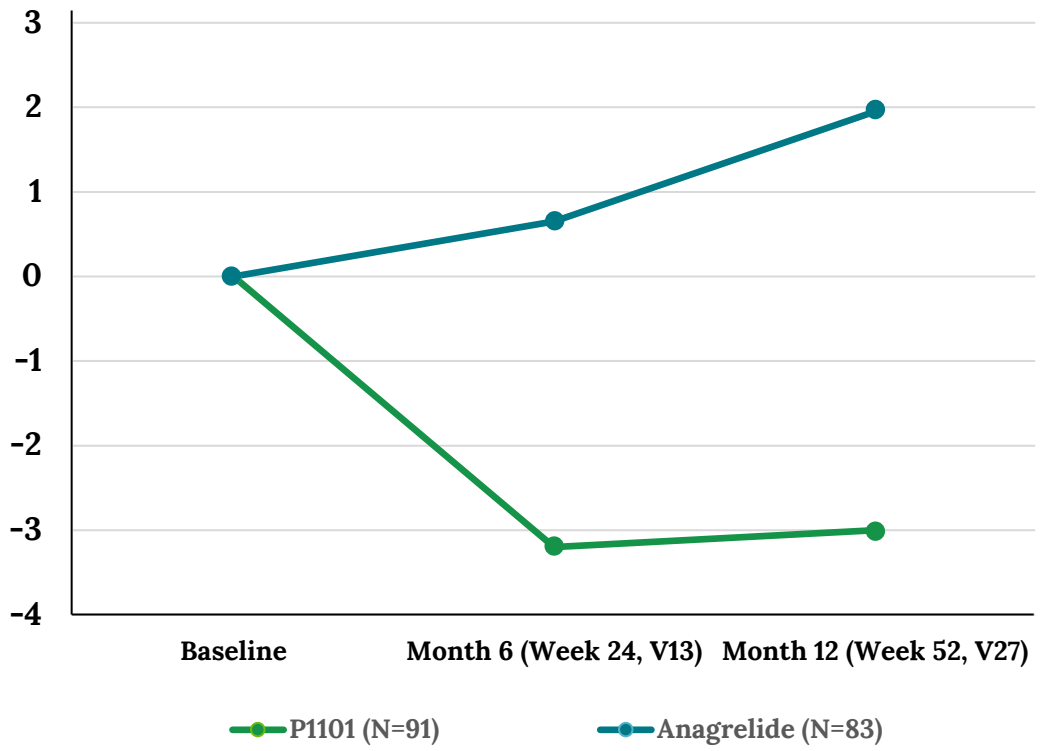
ROPEG在SURPASS-ET試驗中展現亮眼臨床成果，受到國際高度關注

SURPASS ET
ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA

主要評估指標 – Durable Modified ELN Response at Month 9 and 12



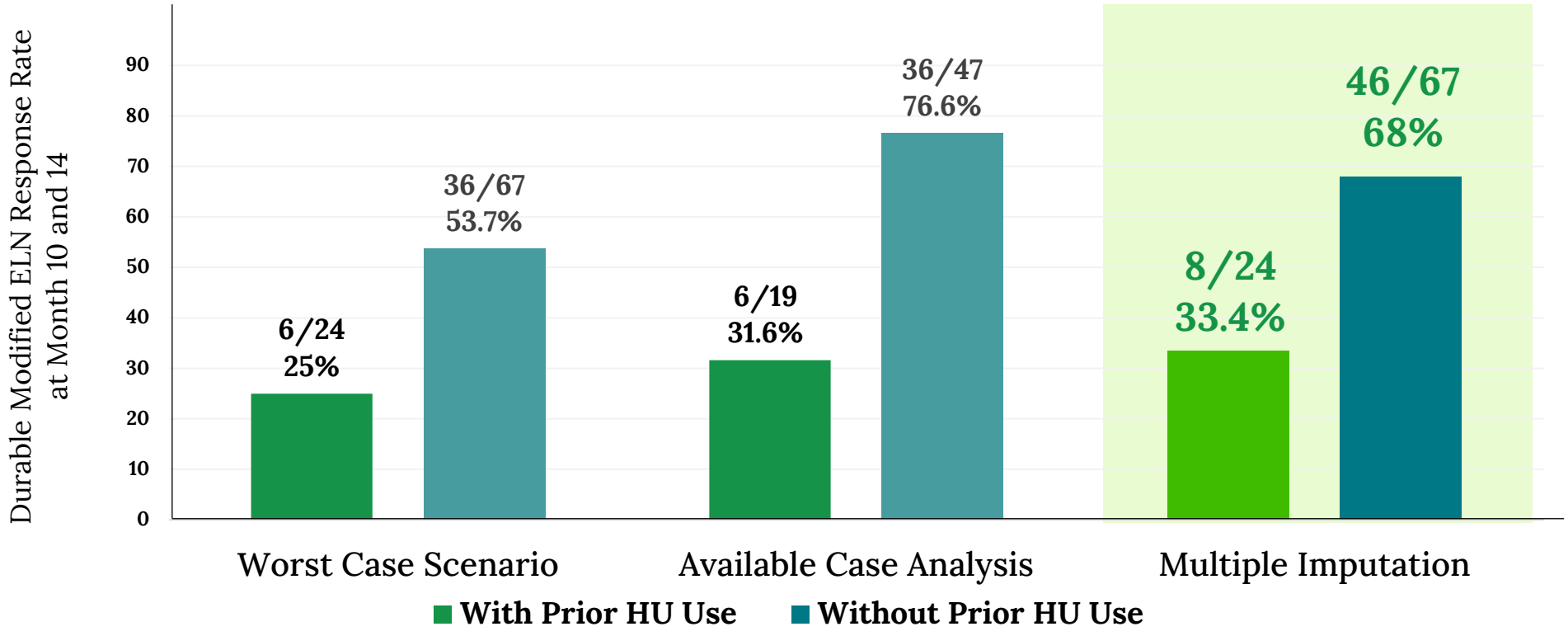
JAK2等位基因負擔(次要)療效評估指標 Baseline and Month 12



PharmaEssentia

EXCEED-ET試驗結果與SURPASS-ET相當，且在未接受過治療的患者中展現更優異的療效

EXCEED 試驗: 接受過HU治療與未接受過HU治療的患者比較



Reference: PEC data on file

PharmaEssentia

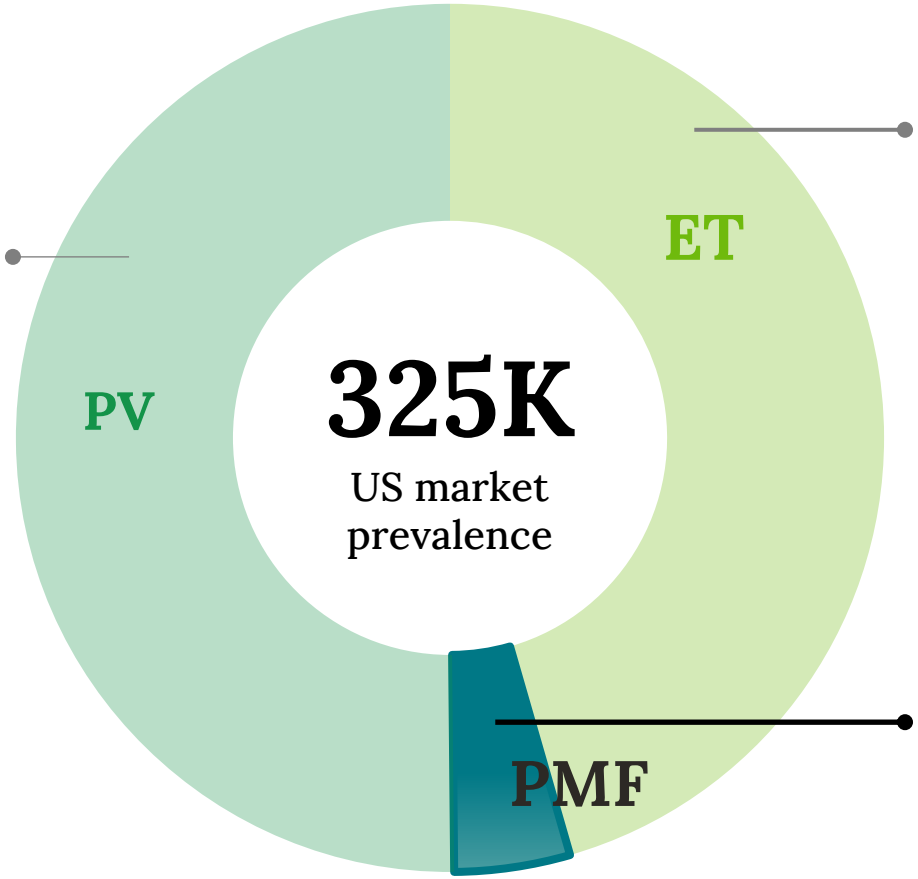
PMF患者族群構成關鍵市場機會，可預防疾病進展為骨髓纖維化

PMF患者族群驅動的高價值市場機會

163K

真性紅血球增多症（PV）

- 2019 歐盟藥證
- 2021 美國藥證
- 2023 日本藥證
- 2024 中國、新加坡、馬來西亞藥證
- 2025 巴西、阿根廷、香港藥證



148K

原發性血小板過多症 (ET)

- SURPASS –2025.01.06 主要數據讀出
- 申請ROPEG進入NCCN指南
- 2025 已完成中國、台灣、及日本送件
- 2025.10.30 已完成美國送件
- 2026.08.30 目標審查完成日期 (PDUFA date)

14K

早前期原發性骨髓纖維化 (PMF)

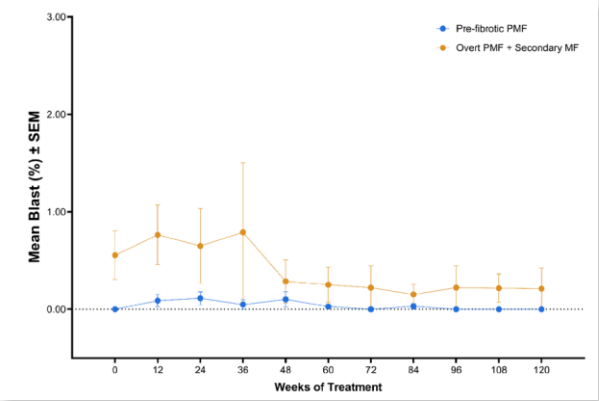
- 三期臨床試驗已啟動，預計2026年Q1完成收案

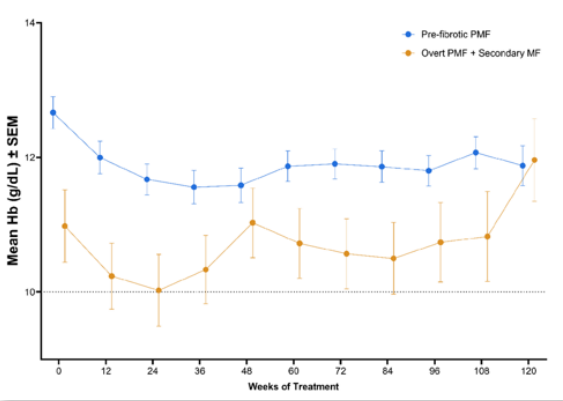
PharmaEssentia

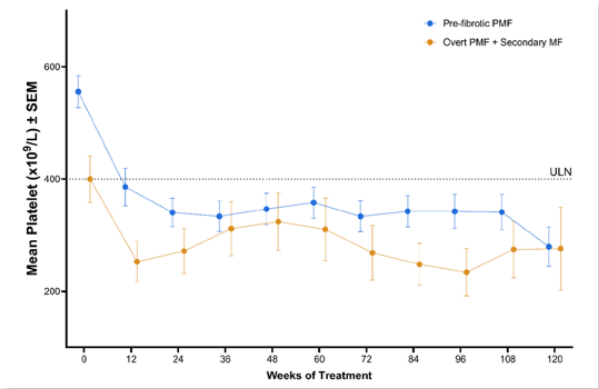
Patient numbers are U.S. prevalence from PharmaEssentia market research
*Source: PharmaEssentia Internal Analyses

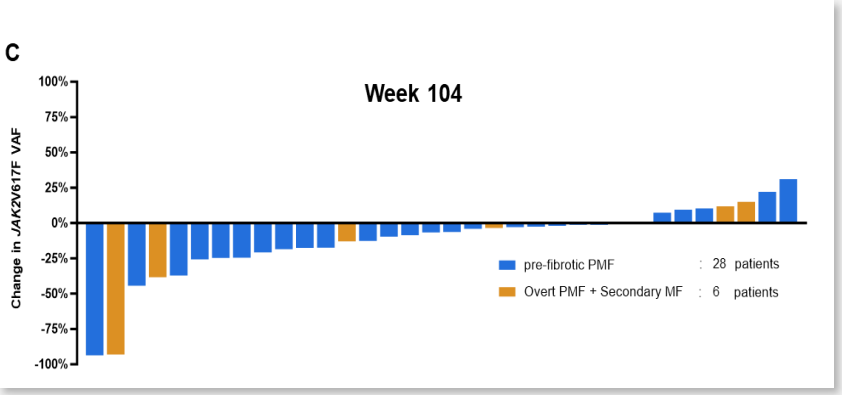
ROPEG PMF IIT兩年臨床成果連續獲ASH、EHA、ASCO國際發表

- 於早期骨髓纖維化、進展期PMF及繼發性MF治療中，ROPEG顯示出顯著的療效，成功維持血紅蛋白（Hb）水平並降低血球數量等臨床、血液學及分子反應指標，顯示出卓越的治療潛力
- 2024年：「P1101MF」研究成果分別於美國血液學會(ASH)及歐洲血液學會(EHA)年會以口頭報告形式發表
- 2025年：連續兩年的試驗成果於美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會以海報論文形式發表
- 2025年：在EHA年會上以口頭報告形式發表，吸引近千名專業人士參與，顯示此試驗在國際血液腫瘤領域的高度關注。









Reference: Gill et al., Ropeginterferon alfa-2b for pre-fibrotic PMF and DIPSS low/intermediate-risk MF, June 12, 2025.

PharmaEssentia

ROPEG 推升近期營收，HOPE-PMF 驅動中長期成長，並預計於2028年擴展新適應症

~150

目標收案人數

Ropeginterferon alfa-2b (P1101) in Pre-fibrotic/ Early PMF

一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心第3期臨床試驗，評估Ropeginterferon alfa-2b (P1101)用於纖維化前期/早期原發性骨髓纖維化或根據DIPSS Plus為低或中度風險1級之明顯原發性骨髓纖維化成人患者的療效及安全性(HOPE-PMF)

試驗參與國家/區域: 美國, 中國 (含香港), 台灣, 韓國, 日本, 新加坡, 加拿大

核心試驗

具有JAK2 V617F突變，
原發性骨髓纖維化前期或 依據
DIPSS Plus為低或中度風險1級明
顯骨髓纖維化患者

R 2:1

實驗組: Ropeginterferon alfa-2b (n ~100)

250(W0) → 350 (W2) → 500(W4)

安全性追蹤

雙盲試驗

治療80周進行指標分析

對照組: 安慰劑 (n ~50)

- 最新進展: 目前已收案 >90名病人，預計3月完成收案

PharmaEssentia

竹北新廠完工生產可
滿足全球 >100,000
名病患用藥需求

ROPEG三期臨床及IIT試驗將加速 新適應症拓展帶動未來增長

實體腫瘤及免疫學

候選產品	適應症	藥物發現	IND 申請準備	PHASE 1*	PHASE 2*	PHASE 3	開發進展
ROPEG	真性紅血球增多症 (PV)						商業化階段: 上市銷售
	原發性血小板過多症 (ET)						藥證申請審查中
	早前期原發性骨髓纖維化 (PMF)						HOPE-PMF 三期臨床試驗進行中
ROPEG + dasatinib	慢性骨髓性白血病 (CML)						一期/二期IIT試驗IND已獲核准
ROPEG + anti PD-1	肝細胞癌 (HCC)						一期臨床數據已發表*
ROPEG	皮膚T細胞淋巴瘤 (CTCL)						一期IIT試驗進行中
	慢性骨髓單核細胞白血病 (CMML)						二期IIT試驗IND準備中
ROPEG + ruxolitinib	骨髓纖維化 (MF)						一期IIT試驗IND已提交

PharmaEssentia

ROPEG (ropeginterferon alpha-2b-njft); Phase 1 HCC data published in Qin et al., Int, J, Mol.Sci 2024; Qin et al., Hepatology Int. 2025;
Cutaneous T cell Lymphoma (CTCL) clinical trial: NCT07047885

2026 年5項產品進入臨床一期Phase 1

腫瘤及免疫疾病領域中具強健的早期階段產品線將推動未來增長

實體腫瘤及免疫學

候選產品		適應症	藥物發現	IND 申請準備	PHASE 1*	開發進展
PEG 細胞激素	PEG-IL-2 (P11838)	免疫疾病				預計2026年上半年提交IND
	PEG-Cytokines	實體腫瘤				預計2027年IND申請準備
雙特異性抗體	PD-1-IL-2v	實體腫瘤				預計2026年IND申請準備
ADC	ADC (novel target)	實體腫瘤				預計2026年IND申請準備
	ADCs					
細胞療法	NY-ESO-1 TCR-T	實體腫瘤				預計2026年IND申請準備
	KRAS TCR-T					

P11838: Data presented at ICIS Cytokine conference, 2025; PD-1-IL-2v: a bispecific immunocytokine combining a PD-1 antibody with an IL-2 variant; ADC: antibody Drug Conjugate; TCR-T, T cell receptor T cell therapy

PharmaEssentia

充足資金助力高潛力產品與產業投資，
加速研發與產品線拓展，持續驅動營收爆發性增長

兩大策略投資:

A TBMC，讓生物製要跑得更快!

- 利用TBMC先進平台，加速生物製藥產品研發，縮短上市時間，滿足全球需求。
- 優化生產與供應鏈效能，推動快速技術突破與市場應用。
- 整合技術與資源，實現協同效應，提升生產效能，確保全球市場需求的穩定供應。

兩大策略投資:

B 鑽鐵資產納入版圖，深化公司在細胞療法領域的布局

- 技術創新：藥華藥波士頓創新研發中心（PIRC）結合國家生技研究園區（NBRP）優程，提升產品品質與生產效率。
- 臨床優勢：利用大陸IIT臨床優勢，加速臨床試驗進展。
- 未來發展：聚焦TCR-T與in-vivo CAR療法，擴大細胞療法領域，滿足全球患者需求。

▼ 藥華醫藥創新研發中心 (PIRC) — 波士頓，美國

▼ 國家生技研究園區 (NBRP)

百億營收，千億夢：四大策略驅動，風險可控，成長飛速

開發頂尖創新藥

開發創新同類最佳（BiC）及首創（FiC）免疫檢查點抑制劑
-推進 TCR-T 細胞療法，針對表面及細胞內抗原
-積極尋求策略合作以擴大研發產品線覆蓋，重點聚焦ADC、雙特異性抗體及細胞療法

擴大PEG技術平台的應用

運用藥華藥的創新PEGylation平台設計長效細胞激素（cytokines）
- 開發 BiC/FiC PEGylated細胞激素（例如 IL-2, IFN-γ）
- 針對難治性腫瘤（腎臟癌、胰腺癌）及免疫介導疾病

擴大ROPEG適應症

ROPEG 新適應症拓展，聚焦高度未被滿足的需求
- 將ROPEG擴展至血液及實體腫瘤相關的新適應症
- 探索ROPEG與其他分子聯合療法，例如與anti PD-1聯用於肝細胞癌等疾病

引領全球MPN治療發展

確立ROPEG為全球MPN治療標準
ROPEG已在多國取得PV藥證並上市
- ET: 2025年已完成美國、中國、台灣、及日本的送件
- MF: 早前期原發性骨髓纖維化 或 低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化

PharmaEssentia

藥華醫藥股份有限公司

Better Science, Better Lives.

PharmaEssentia